Bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie, dont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (au 1er janvier 2025)

Documentation

Mise en ligne le 26/02/2026

©Insee *Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie*

Historique des mises à jour

26 février 2026 : mise en ligne des données

Source

Caisse Nationale d'Assurance Maladie - Bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie au 1er janvier 2025.

Précautions d'utilisation

Les données issues de la source Cnam sont des données structurelles. Deux millésimes consécutifs ne doivent pas être utilisés pour mesurer des évolutions aux niveaux infra-communaux (Iris). En effet, les évolutions entre deux millésimes ne reflètent pas uniquement l'évolution réelle, elles traduisent aussi les améliorations de géolocalisation des adresses.

Par ailleurs, les différentes modifications de champ au fil des millésimes (intégration de nouvelles catégories de population, gestion des adresses administratives, sélection des bénéficiaires réellement affiliés) entraînent de fortes évolutions du nombre de personnes couvertes par le régime général. Par conséquent, l'utilisation des données en évolution est fortement déconseillée.

En raison de la méthode de gestion du secret employée (cf. Secret statistique), les égalités comptables ne sont pas systématiquement respectées. Par exemple, le nombre de bénéficiaires du régime général ne coïncidera pas nécessairement avec la somme du nombre de bénéficiaires hommes et femmes. Toutefois, ces écarts ne dépassent pas quelques unités.

Pour calculer des taux, utiliser au dénominateur la somme des modalités de la variable : par exemple, le taux de bénéficiaires du régime général hommes est à calculer en rapportant le nombre de bénéficiaires hommes à la somme des bénéficiaires hommes et des bénéficiaires femmes.

Note de diffusion

Modalités :

0: Aucun problème particulier
2: Données non diffusées en raison de fusion de communes rendant la géolocalisation incertaine
3: Données non diffusées en raison du seuil de diffusion
4: Données non diffusées en raison d'une mauvaise qualité de géoréférencement
5: Données non diffusées en raison d'anomalies repérées lors des contrôles de cohérence

Priorité :

Une zone peut, en théorie, avoir plusieurs notes. La priorité est la suivante:
note 2 / note 4 / note 3 / note 5
Par exemple, un Iris de moins de 100 personnes (note 3) dont les adresses sont géoréférencées avec une
Les données des zones diffusées (note 0) sont traitées pour garantir le secret statistique

Gestion des adresses administratives

Dans le traitement des données Cnam, les adresses correspondant à des adresses administratives (adresses de domiciliation qui ne correspondent pas à une présence physique réelle des allocataires : sans-domicile fixe, gens du voyage et autres personnes non inscrites à leur domicile mais à l'adresse de leur organisme de rattachement) sont repérées afin d'être exclues des agrégations sur les échelons infra-communaux (Iris), de façon à ne pas introduire de surreprésentation artificielle.

Qualité du géoréférencement

La note de diffusion d'un iris est égale à 4 quand l'Iris contient moins de 90 % d'adresses correctement géoréférencées.

Les adresses correctement géoréférencées correspondent aux adresses géoréférencées de manière « sûre » et à une partie des adresses géoréférencées de manière « probable », dont l'expertise conduite indique une probabilité élevée de bonne localisation dans l'Iris.

Définitions

La **population couverte** recouvre les assurés et leurs ayants droit.
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 organise la suppression progressive du statut d'ayant-droit. Toute personne majeure qui n'a pas d'activité professionnelle « a droit à la prise en charge de ses frais de santé dès lors qu'elle réside en France de manière stable et régulière ». Cette opération d'individualisation et d'autonomisation de la gestion des droits, menée dans le courant de l'année 2019, a pour conséquence que les ayants-droits majeurs sans activité professionnelle initialement rattachés à la sécurité sociale de leur conjoint deviennent des assurés à part entière. Seuls les enfants restent donc des ayants droit.

Le dispositif de complémentaire santé solidaire
La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) avait pour objectif de faciliter l'accès aux soins et de contribuer à la réduction des inégalités de santé en proposant aux personnes aux faibles ressources, et résidant en France de façon stable et régulière, une couverture maladie complémentaire gratuite.
La **C2S (Complémentaire Santé Solidaire)** a été mise en place au 1er novembre 2019, en remplacement de la CMU-C et de l'Aide à la Complémentaire Santé (ACS). La Complémentaire santé solidaire est une aide de l'Etat qui permet aux foyers modestes de bénéficier d'une mutuelle gratuite ou à moins de 1 euro par jour et par personne. Selon les ressources du foyer, la Complémentaire santé solidaire peut ainsi être sans participation financière (ex CMUC) ou avec participation financière (ex ACS).

Pour en savoir plus sur la C2S : https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/

Répartition par tranche d'âge : A compter du millésime 2020, les bénéficiaires du régime général, dont ceux de la C2S, sont ventilés selon des tranches d'âge couvrant l'ensemble du champ.
Ainsi les 18-24 ans, auparavant exclus du fait de la non inclusion des régimes étudiants, ont été ajoutés.
Les personnes de plus de 60 ans bénéficiant de la C2S sont également ajoutés. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) bénéficient d'une présomption de droits à la complémentaire santé solidaire avec participation financière, sous réserve que leurs ressources ne dépassent pas le plafond d'attribution. En revanche, les ressources des bénéficiaires de l'ASPA dépassent généralement le plafond d'attribution à la C2S non participative.

Champ

Les indicateurs concernant les bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie sont issus des fichiers des Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM).
Depuis le millésime 2020, sont intégrées dans le régime général de l'assurance maladie :
- les SLM (Sections Locales Mutualistes) étudiantes LMDE et SMER
- les SLM de fonctionnaires MFPS et HFP

De plus, les nouveaux travailleurs indépendants ont été affiliés directement au régime général depuis le 1er janvier 2019 et le stock des travailleurs indépendants a été intégré ultérieurement, après le 1er janvier 2020.

Le **champ couvert** est ainsi celui des bénéficiaires du régime général, y compris les étudiants, les travailleurs indépendants, et une partie des SLM de fonctionnaires, ainsi que toute personne bénéficiant de droit à l'assurance maladie au titre de la résidence (Protection Universelle Maladie ou PUMA).
Sont exclus du champ de ces données :
- les bénéficiaires de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), de la mutuelle des agents du service public (Interiale) et de la mutuelle générale de la police (MGP)
- les bénéficiaires des autres régimes d'assurance maladie : le régime agricole (MSA), qui prend en charge les exploitants et salariés agricoles et les régimes spéciaux, comme celui de la SNCF, de la RATP, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des clercs de notaires, etc.

Le régime général couvre la majeure partie de la population (environ 90%).
Modification du champ à compter du millésime 2021 :
Suite à une analyse avec le producteur des données du statut de rattachement des individus aux organismes de l'assurance maladie, il a été décidé de comptabiliser les bénéficiaires uniquement dans l'organisme où leur rattachement est certifié. Au niveau national, environ 800 000 personnes non encore affiliées ou pour lesquelles l'affiliation est en cours de modification entre organismes ne sont donc plus comptabilisées.

Géographie

Le découpage géographique des communes et des Iris est celui en vigueur **au 1er janvier 2025.**
Les données communales incluent les communes de Paris, Lyon et Marseille ainsi que leurs arrondissements municipaux.

Secret statistique et confidentialité

Secret statistique

Jusqu'au millésime 2023, la méthode de gestion du secret statistique jusqu'alors appliquée consiste à blanchir les données permettant de révéler une information portant sur un nombre trop faible d'unités. A partir du millésime 2024, année de la diffusion conjointe sur les 2 générations de quartiers de la politique de la ville (QPV2015 et QPV2024), la méthode de gestion du secret a évolué afin de pallier les risques accrus de rupture du secret ; en particulier par différentiation géographique liés à cette double diffusion.

La méthode retenue dite des clés aléatoires (cell key method) consiste à modifier toutes les cases d'un tableau de données en injectant une déviation aléatoire à la hausse ou à la baisse suffisamment faible pour ne pas engendrer d'impact statistique et suffisamment élevée pour empêcher la révélation d'information. La déviation n'excède pas une valeur fixée (cf. Déviation maximale). Concrètement, si la déviation aléatoire vaut +2, la valeur originale d'une case d'un tableau de données de 250 sera remplacée par la valeur 252.

Comparativement à la méthode de blanchiment, la méthode des clés aléatoires permet donc de diffuser davantage d'information tout en garantissant le secret statistique. En revanche, la méthode ne garantit plus les égalités comptables internes au tableau de données (cf. Précautions d'utilisation).

Pour en savoir plus : le billet de blog.

Déviation moyenne : +/-4
Déviation maximale : +/-15
Seuil de confidentialité : 11

Format des fichiers csv

Les fichiers csv sont encodés en UTF-8.

Le délimiteur est le point-virgule.

La longueur et le format des variables des fichiers data_....csv sont spécifiés dans les fichiers meta_….csv correspondants.